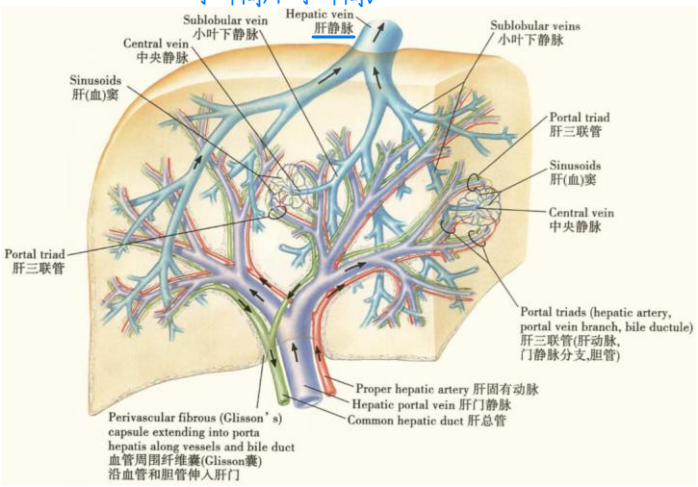
肝前型	肝外门静脉血栓形成、先天性畸形、肿瘤压迫	肝硬化患者一般到后期时肝脏缩小
肝后型	缩窄性心包炎、右心衰、肝静脉血栓形成 **Budd-Chiari 综合征（肝静脉和/或下腔静脉阻塞）**	淤血性肝硬化：常伴肝肿大 淤血、淤胆、淤虫、酒精肝脏可以肿大
肝内型	窦后性阻塞：中央静脉和小叶下静脉受压 窦性阻塞：肝血窦受压 窦前性：肝内肝动脉-门静脉异常吻合支	肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞，而血吸虫主要为窦前阻塞（虫卵较大进不去肝血窦）

小叶间A-小叶间V



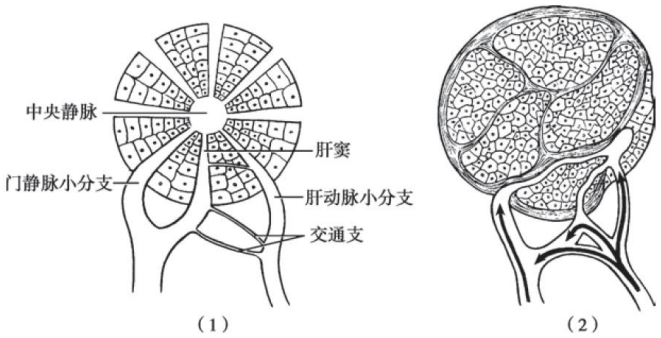


图 43-2　门静脉、肝动脉小分支之间的交通支在门静脉高压症发病中的作用（1）正常时，门静脉、肝动脉小分支分别流入肝窦，它们之间的交通支细且不开放　（2）肝硬化时，交通支开放，压力高的肝动脉血流注入压力低的门静脉，从而使门静脉高压进一步加重

三、胃镜在食管胃底静脉曲张的价值

①**诊断**金标准；②评估出血危险程度；③止血；④鉴别上消化道出血原因

四、治疗

（一）预防食管胃底静脉曲张出血 将来时

1.曾有出血→**择期断流术**

外科处理明显的脾大脾亢:做手术-切脾
内科处理明显的脾大和脾亢:做脾动脉栓塞

病例题一般关注红色征

2.未出血者：①**多内科保肝**；②重度静脉曲张**红色征**、或伴明显脾大脾亢→**预防性断流术**

轻度脾大:脾未超过肋下2cm
明显脾大:脾跨过前正中线/脐
脾亢:破坏plt→WBC→RBC

任何手术都会打击肝功能　V内大量淤血　e.g全血C↓、plt<30

（二）控制食管胃底静脉曲张出血（3P 治生态）进行时

收缩压＜90：补充血容量
生长抑素/奥曲肽:①治疗食管胃底V破裂出血 ②急性胰腺炎③倾倒综合征④镇脉类中毒 **内镜曲张食管静脉套扎术 EVL** 胃底V是翘起来的,无法套扎 + VS消化性溃疡导致的上消化道出血:止血时首选奥美拉唑 **生长抑素/奥曲肽**（收缩内脏血管→减少门静脉血流量→降低门静脉压）选择性收缩消化道血管,对全身血管影响较VP小 （也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇高官运衰）
PPI 抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管临时止血（对胃底静脉压迫效果差）　容易缺血坏死
保守治疗无效：Child A、B 级→急诊断流术；Child C 级→TIPS

《内科》:3P治生态,EVL全都有

肝功能 Child-Pugh 分级依据：**白/清蛋白、腹水、凝血酶原延长时间、胆红素、肝性脑病**（白富美单干）

肝功能太差不宜手术　经颈V肝内门体/腔分流术(消化内科yyds)

注意：**Child C 级**（**黄疸+腹水**黄水，腹水如移动性浊音）暂时不手术，可 **TIPS（食管胃底静脉曲张出血）、TACE（肝细胞癌）**　介入(微创)

肝A化疗栓塞